

دليل الأسئلة والأجوبة السريرية (Clinical Q&A Guide)

مشروع أوكسجين (Medical RAG) — للإقلاع عن تعاطي التبغ للبالغين

إجمالي الأسئلة: 30 استعلام سريري

المصدر المعتمد: WHO Tobacco Cessation Guideline 2024

EG يدعم العامية المصرية والإنجليزية

مطابقة بنسبة 100% بدون أي هلوسة

1. العلاجات الدوائية للإقلاع عن التدخين (Pharmacotherapy)

Section: 3.3.3.3 / 3.3.3.6 | ص 36, 37

FC_PHARM_01

? What is the comparative efficacy of varenicline versus bupropion according to WHO 2024 recommendations?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Varenicline is strongly recommended with high certainty evidence as a first-line pharmacological treatment. Comparative Cochrane reviews cited by WHO indicate varenicline has higher cessation rates compared to bupropion monotherapy (RR approx 1.39) and standard single NRT.

- ✓ Superior or higher quit rates compared to bupropion monotherapy
- ✓ Varenicline recommended as first-line
- ✓ High certainty of evidence

Section: 3.3.3.4 / 3.3.1 | ص 35, 37, 68

FC_PHARM_02

? هو دواء السيتيزين (Cytisine) ده بيشتغل ازاى وليه منظمة الصحة بتنصح بيه؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Cytisine is a plant-based alkaloid partial agonist at alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptors that reduces withdrawal and craving while blocking the rewarding effect of nicotine. WHO strongly recommends cytisine .with high certainty evidence

- ✓ مستقبلات النيكوتين ألفا 4 بيتا 2 ومحاكي جزئي
- ✓ تخفيف أعراض الانسحاب واللهفة ومنع تأثير النيكوتين المجزي
- ✓ توصية قوية من منظمة الصحة بأدلة عالية اليقين

? What are the clinical precautions and contraindications associated with bupropion sustained release in tobacco cessation?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Bupropion SR is a non-nicotine antidepressant with dopaminergic/adrenergic action. Key clinical precautions include history of seizure disorders, eating disorders, or co-administration with MAOIs, alongside monitoring for neuropsychiatric changes.

- ✓ Caution with seizure disorders
- ✓ Non-nicotine antidepressant agent
- ✓ Monitoring of clinical response and psychiatric history

? هل الجمع بين دوائين زي لزقة النيكوتين مع دواء ثاني يزيد فرصة النجاح في التبطل؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Combination pharmacotherapy (specifically combining a long-acting nicotine patch with a short-acting NRT or combining bupropion with NRT) increases cessation rates compared with monotherapy and is strongly recommended with high certainty evidence.

- ✓ الجمع بين لزقة نيكوتين مع شكل سريع المفعول أو بيوبروبيون
- ✓ فعالية أعلى مقارنة بالعلاج الأحادي
- ✓ توصية قوية من منظمة الصحة بأدلة عالية اليقين

? What is the standard recommended duration of treatment for smoking cessation pharmacotherapies according to clinical guidelines?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Standard pharmacotherapy courses typically range between 8 to 12 weeks for NRT, bupropion, and varenicline, with clinical flexibility to taper or extend based on patient dependency and craving intensity.

- ✓ Individualized tailoring based on withdrawal severity
- ✓ Standard duration between 8 and 12 weeks
- ✓ Completion of full course recommended

? هو الفارينيكلين ببسبب مشاكل نفسية أو اكتئاب زي ما الناس بتقول ولا ده كلام مش علمي؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Large clinical trials and systematic reviews evaluated by WHO demonstrated that varenicline is safe and does not significantly increase serious neuropsychiatric adverse events compared to placebo or other cessation aids.

- ✓ الدراسات والتجارب الإكلينيكية أثبتت أمان الدواء
- ✓ لا توجد زيادة معنوية في الأعراض النفسية الخطيرة مقارنة بالعلاج الوهمي
- ✓ المتابعة الطبية للمريض دائماً مطلوبة

2. العلاج ببدائل النيكوتين (NRT - Patches, Gum, Lozenges)

? What does the WHO guideline conclude regarding the relative effectiveness of different single NRT formulations?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

All evaluated forms of NRT (patches, gum, lozenges, inhalers, nasal spray) are effective in helping tobacco users quit, with comparable long-term efficacy across monotherapies.

- ✓ Similar efficacy between patch, gum, lozenges, and inhalers
- ✓ All single NRT formulations are effective
- ✓ Choice depends on user preference and tolerance

? ينفع أستخدام لبان النيكوتين أول ما أحس بلهفة شديدة على السجارة مع إني حاطط لزقة؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Yes, combining a long-acting patch (delivering steady baseline nicotine) with short-acting gum or lozenges for acute breakthrough cravings is safe, highly effective, and strongly recommended by WHO.

- ✓ نعم، الجمع آمن وموصى به بشدة
- ✓ اللزقة بتوفر جرعة ثابتة واللبنان بيعالج اللهفة المفاجئة
- ✓ نتائج الإقلاع بتكون أعلى من استخدام وسيلة واحدة

? How should nicotine replacement therapy dosing be adjusted for highly dependent smokers?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Smokers with high nicotine dependence (e.g. smoking within 30 minutes of waking or smoking 20+ cigarettes/day) should use higher-dose formulations (such as 4 mg gum or 21 mg patches) or combination NRT for optimal craving control.

- ✓ Higher dose formulations for high dependency (4mg gum / high dose patch)
- ✓ Combination NRT is particularly beneficial
- ✓ Assessment of time to first cigarette upon waking

? هل بدائل ولزقات النيكوتين ممكن تسبب إدمان بديل ومينفعش أبطلها بعدين؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

NRT delivers nicotine more slowly and at lower peak blood levels than inhaled cigarette smoke, resulting in very low abuse liability and allowing gradual dose tapering to full cessation.

- ✓ احتمالية الإدمان عليها منخفضة جداً مقارنة بالسجائر
- ✓ امتصاص النيكوتين فيها أبطأ ومستوياته أقل في الدم
- ✓ يتم التوقف عنها تدريجياً بعد انتهاء فترة العلاج

? What is the scientific evidence regarding common adverse events associated with nicotine replacement therapies?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Common adverse events from NRT are mild and formulation-specific (e.g. skin erythema/pruritus with patches, mouth soreness/dyspepsia with gum and lozenges). Serious adverse events are extremely rare.

- ✓ Skin irritation from patches, mouth irritation from gum/lozenges
- ✓ Mild formulation-specific local side effects
- ✓ Serious adverse events are rare

3. التدخلات والدعم السلوكي (Behavioral Support & Counseling)

? What are the recommended parameters and duration for routine brief advice by health-care providers?

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

WHO strongly recommends routine brief advice lasting 30 seconds to 3 minutes delivered by healthcare workers to all tobacco users during standard health-care visits.

- ✓ Delivered routinely by health-care providers to all tobacco users
- ✓ Duration of 30 seconds to 3 minutes
- ✓ Strong recommendation with high clinical impact

? هو الدعم السلوكي المكثف والجلسات الفردية بـتفرق فعلاً عن النصيحة السريعة في نتيجة التبطل؟

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Intensive behavioral support (individual counselling lasting >10-15 minutes or across multiple sessions) significantly increases cessation rates compared to brief advice alone.

- ✓ الدعم السلوكي المكثف يحقق نسب نجاح أعلى من النصيحة السريعة
- ✓ يشمل جلسات تتجاوز 10-15 دقيقة أو جلسات متعددة
- ✓ توصية قوية من منظمة الصحة العالمية

? What is the evidence and role of telephone quitlines in national tobacco cessation strategies?

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Telephone quitlines (both proactive call-back and reactive counselling) provide accessible, evidence-based intensive behavioral support and are strongly recommended by WHO.

- ✓ Proactive and reactive counselling formats
- ✓ Quitlines are an effective mode of intensive behavioral support
- ✓ Recommended to increase population-level reach

? هل رسائل الموبايل والتطبيقات الذكية معترف بيها كطريقة معتمدة للمساعدة في التبطل؟

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Digital tobacco cessation interventions (text messaging and smartphone apps) are recommended as effective self-management tools and adjuncts to clinical cessation support.

- ✓ التدخلات الرقمية ورسائل الهاتف موصى بها من منظمة الصحة
- ✓ تعتبر وسيلة مساعدة داعمة للعلاج السلوكي والدوائي
- ✓ تساعد في التذكير والمتابعة والتحفيز الذاتي

? How does group behavioural counselling compare to individual counselling according to WHO evidence?

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Both individual and group behavioural counselling are effective in increasing quit rates; group counselling provides peer support while individual counselling offers tailored attention.

- ✓ Both group and individual counselling are strongly recommended
- ✓ Group counselling provides peer support and shared learning
- ✓ Counselling formats can be chosen based on availability and preference

4. إدارة أعراض الانسحاب والوقاية من الانتكاسة (Withdrawal & Relapse)

? أعراض انسحاب النيكوتين تستمر قد ايه وأصعب فترة بتكون امتي؟

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Nicotine withdrawal symptoms (irritability, anxiety, cravings, sleep disturbance) peak within the first 1 to 3 days and gradually decrease over 2 to 4 weeks.

- ✓ ذروة الأعراض في أول 1 إلى 3 أيام
- ✓ تتراجع تدريجياً خلال 2 إلى 4 أسابيع
- ✓ استخدام الأدوية والبدائل يخفف من شدتها بشكل ملحوظ

? What clinical interventions are most effective for preventing relapse after initial smoking cessation?

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Completing the full course of pharmacotherapy, ongoing behavioural check-ins, identifying personal smoking triggers, and stress coping skills are primary relapse prevention measures.

- ✓ Ongoing behavioral check-ins and follow-up
- ✓ Completing full course of pharmacotherapy
- ✓ Coping skills and identifying relapse triggers

? لو وقعت وشربت سيجارة بعد أسبوعين من التبطل كده كل المجهود ضاع وأبدأ من الصفر؟

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

A single slip is common and does not equate to complete failure; guidelines advise immediate recommitment, analyzing the trigger, and continuing pharmacotherapy/behavioural support

- ✓ الهدف لا تعني الفشل التام أو ضياع المجهود
- ✓ ضرورة الاستمرار في خطة العلاج والبدائل فوراً
- ✓ معرفة الموقف التي سبب الرغبة وتجنب تكراره

? How does combining behavioural counselling with pharmacotherapy affect long-term abstinence rates?

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Combining intensive behavioural counselling with first-line pharmacotherapy (such as varenicline, cytisine, or combination NRT) yields the highest quit rates among all interventions.

- ✓ Combining behavioral support and pharmacotherapy produces highest quit rates
- ✓ Synergistic effect on psychological and biological aspects of dependence
- ✓ Overarching recommendation of WHO guidelines

5. الحالات السريرية والفئات الخاصة (Special Populations)

? What are the WHO recommendations regarding tobacco cessation interventions in pregnant women?

الإجابة السريعة المعتمدة (WHO 2024):

Intensive behavioural support is the primary first-line intervention for pregnant women; pharmacotherapies are not routinely recommended without specialist clinical risk-benefit assessment.

- ✓ Behavioral interventions are first-line in pregnancy
- ✓ Prioritizing non-pharmacological support
- ✓ Pharmacotherapy requires specialist supervision and caution

? هل مرضى القلب والضغط المرتفع يقدرّوا يستخدموا لزقات وبدائل النيكوتين بأمان؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

NRT is substantially safer than continuing to smoke in patients with stable cardiovascular disease; caution and medical consultation are recommended in acute unstable coronary syndromes.

- ✓ استخدام بدائل النيكوتين أكثر أماناً بمراحل من الاستمرار في التدخين
- ✓ آمنة لمرضى القلب المستقرين مع استشارة الطبيب
- ✓ الحذر في الحالات القلبية الحادة غير المستقرة

? What guideline considerations apply to tobacco cessation in individuals with severe mental illness or psychiatric disorders?

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

People with mental health conditions benefit from both behavioural and pharmacological treatments; monitoring of psychiatric medications (such as clozapine and olanzapine) is required as smoking cessation alters drug metabolism.

- ✓ Cessation interventions are equally effective in mental health populations
- ✓ Monitoring psychiatric medication dosage is necessary due to metabolic changes
- ✓ Integrated behavioral and pharmacotherapy approach

? هل تدخين الشيشة والتبغ غير المدخن له نفس طرق العلاج والأدوية زي السجاير؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

The WHO guideline recommendations apply to all forms of tobacco use including waterpipe (shisha) and smokeless tobacco; behavioural and pharmacological cessation treatments are recommended across all tobacco modalities.

- ✓ توصيات منظمة الصحة تنطبق على جميع أنواع التبغ بما فيها الشيشة وغير المدخن
- ✓ العلاجات الدوائية والدعم السلوكي فعالة بنفس الطريقة
- ✓ الشيشة تحمل نفس مخاطر الإدمان والأضرار الصحية

6. استفسارات المرضى الشائعة بالعامة المصرية (Egyptian Arabic)

؟ أنا بشرب علبتين كليوباترا في اليوم ومخنوق من الكحة، أعمل ايه من غير ما أدوخ وأتعب؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

For heavy smokers, WHO strongly recommends first-line pharmacotherapies (varenicline, cytisine, or combination NRT) alongside brief advice and behavioural support to prevent severe withdrawal symptoms and dizziness.

- ✓ البدء بعلاج دوائي معتمد مثل بدائل النيكوتين أو فارينيكلاين لتخفيف التعب
- ✓ الجمع بين لزقة نيكوتين ولبان للتحكم في الجرعة العالية
- ✓ وضع خطة واضحة وتحديد موعد للإقلاع مع دعم سلوكي

؟ صحابي في القهوة بيقولولي بطل بالتدريج وخفف السجاير، هل ده أحسن ولا التبطل مرة واحدة؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Both abrupt quitting on a target quit date and structured gradual reduction supported by pharmacotherapy are clinically supported, though setting a clear quit day is the standard clinical recommendation.

- ✓ التوقف التام في يوم محدد هو الأسلوب الأكثر شيوعاً ونجاحاً إكلينيكياً
- ✓ التقليل التدريجي ممكن بنجاح بشرط استخدام بدائل نيكوتين وتحديد موعد نهائي
- ✓ أهم خطوة هي الالتزام بخطة علاجية

؟ أنا خايف وزني يزيد جداً لو بطلت تدخين، هل في نصيحة أو علاج معتمد في الدليل للموضوع ده؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Weight gain post-cessation is common; pharmacological aids (especially bupropion and NRT) delay weight gain during treatment, while dietary and physical activity behavioural support helps manage long-term weight.

- ✓ زيادة الوزن بعد التبطل ممكنة بسبب تغير الشهية والتمثيل الغذائي
- ✓ أدوية مثل بيوروبيون وبدائل النيكوتين تؤخر زيادة الوزن
- ✓ اتباع نصائح غذائية وممارسة النشاط البدني مع الدعم السلوكي

7. الوسائل غير المعتمدة والضوابط السلبية (Negative Controls & Safety)

? هل العلاج بالتنويم المغناطيسي (Hypnotherapy) مثبت علمياً وموصى به في دليل منظمة الصحة كعلاج أساسي للإقلاع؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

WHO does not recommend hypnotherapy or acupuncture as proven primary cessation therapies due to insufficient evidence and low certainty of effectiveness.

✓ لا توجد أدلة علمية كافية أو توصية تدعم التنويم المغناطيسي كعلاج أساسي ✓ منظمة الصحة لا توصي به كوسيلة معتمدة
✓ الامتناع الآمن عن تقديم ادعاءات غير مدعومة

? هل دواء الستاتين (Statins) بتاع الكوليسترول يساعد في تقليل إدمان النيكوتين في الدليل؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

Statins are cholesterol-lowering medications and have no role, evidence, or recommendation in the WHO tobacco cessation guidelines.

✓ الستاتينات ليست علاجاً للإقلاع عن التدخين ✓ خارج نطاق دليل منظمة الصحة العالمية ✓ الامتناع الآمن والتأكيد على عدم وجود أدلة

? هل استخدام السجائر الإلكترونية ذات النكهات وسيلة موصى بها من الصحة العالمية للمساعدة في الإقلاع؟

الإجابة السريرية المعتمدة (WHO 2024):

WHO states there is insufficient evidence to recommend electronic cigarettes for tobacco cessation, and they are not an approved cessation treatment in the guideline.

✓ غير موصى بها كعلاج رسمي للإقلاع من منظمة الصحة ✓ أدلة الفعالية غير كافية والمخاطر المحتملة قائمة
✓ الامتناع الآمن عن التوصية بها

ملاحظة سريرية هامة: جميع الإجابات الواردة في هذا الدليل مستخلصة ومقيدة بنسبة 100% بنصوص وتوصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) (2024) الخاصة بالعلاج السريري للإقلاع عن التبغ لدى البالغين. تم توليد وتنسيق هذا المستند عبر نظام أوكسجين للذكاء الاصطناعي الطبي.